ACTA No.4 -2025
APLICACIÓN INSTRUMENTO ISABEL
Instrumento de Seguridad para la Atención Obstétrica

FECHA REUNIÓN	21 DE NOVIEMBRE DE 2025		
LUGAR:	ESE HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA		
HORA INICIO:	8:00 a.m	**HORA FINALIZACIÓN:**	3: 00 p.m
RESPONSABLES:	Equipo salud sexual y reproductiva – línea maternidad segura		
ASISTENTES:	Se adjunta lista de asistentes. Se adjunta lista de asistentes. Formato (E-DO-TH-F-003)		
OBJETIVO:	**1.** Aplicar instrumento de evaluación de la respuesta institucional frente a la emergencia obstétrica ISABEL, seguimiento. **2.** Realizar asistencia técnica en paquetes instruccionales – prácticas claves que salvan vidas en la emergencia obstétrica. **3.** Analizar y evaluar las condiciones de prestación del servicio en el componente de Maternidad Segura en la Red de Prestación de Servicios de Salud en el departamento de Boyacá con enfoque de garantía de la calidad en la atención de las mujeres antes, durante y post evento obstétrico.		

ORDEN DE DÍA

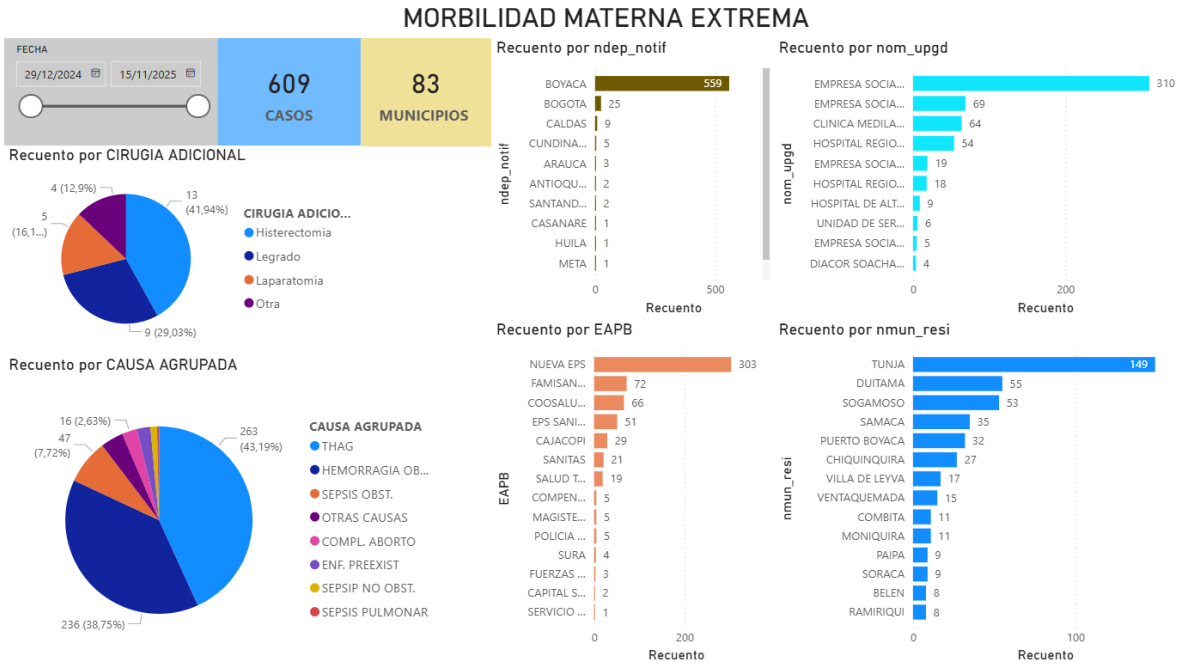
1. Presentación del equipo por parte de Secretaría de Salud, Profesionales de apoyo del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Dirección de Promoción y Prevención y del Equipo de Atención gestantes de la ESE HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA .
2. Indicar objetivos de la visita
3. Realizar asistencia técnica en paquetes instruccionales – prácticas claves que salvan vidas en la emergencia obstétrica indicados desde el instrumento ISABEL y PARE MM
4. Retroalimentación de los hallazgos y compromisos
5. Cierre de la visita

DESARROLLO

Se da inicio a la visita con la socialización de los objetivos y dinámica que se llevará a cabo, (asistencia técnica y verificación de procesos de atención materno perinatal), por parte de las profesionales de la Secretaría de Salud de Boyacá, ante los funcionarios asistentes de la IPS, cuyo propósito es realizar una revisión general de la calidad de la tención materno perinatal, acompañada de un proceso de aclaración de dudas, inquietudes y asesoramiento para el mejoramiento en la implementación de la ruta materno perinatal (con enfoque en atención a emergencias obstétricas), se explica a los asistentes que los compromisos pactados en esta visita, serán objeto de seguimiento posterior por parte del equipo delegado de la Dirección Técnica de prestación de servicios de la Secretaría de salud de Boyacá, en el marco del cumplimiento de los lineamientos impartidos en las circulares 005 de 2012, 016 del 2017 y 047 de 2022 y circulares departamentales.

Durante el periodo comprendido entre el 29/12/2024 y el 15/11/2025 se registraron 609 casos de Morbilidad Materna Extrema (MME) en 83 municipios, con una marcada concentración en Boyacá (559 casos) y en municipios como Tunja, Duitama y Sogamoso, que evidencian una alta carga asistencial y dependencia de la red departamental. Las instituciones con mayor número de notificaciones son las ESE y clínicas de referencia, lo que sugiere alta complejidad en la atención y posibles remisiones tardías desde IPS de menor nivel. Las EAPB con mayor carga son Nueva EPS (303 casos), Famisanar y Coosalud, reflejando la necesidad de fortalecer la gestión del riesgo materno. En cuanto a causas, predominan los trastornos hipertensivos del embarazo (43,1%) y la hemorragia obstétrica (38,8%), que en conjunto

representan más del 80% de los casos y se asocian a procedimientos como histerectomía (41,9%) y laparotomía, indicando severidad del cuadro clínico y la importancia de fortalecer la detección temprana, adherencia a protocolos obstétricos, y oportunidad en la remisión. En general, los resultados reflejan la necesidad de robustecer la calidad de la atención en el primer y segundo nivel, optimizar los tiempos de respuesta institucional, y exigir a las EAPB planes de mejora que garanticen seguimiento adecuado a gestantes de alto riesgo.



En conjunto, los indicadores muestran una tendencia al incremento moderado de la MME, persistencia de causas prevenibles y variabilidad significativa entre municipios y aseguradoras, lo que orienta acciones de vigilancia, asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades para garantizar la calidad de la atención materna.

Se realizó seguimiento a la adherencia institucional en el marco del Instrumento de Evaluación de la Respuesta Institucional frente a la Emergencia Obstétrica – ISABEL, aplicado en los servicios de atención a gestantes. Este instrumento permite valorar la capacidad instalada y las competencias institucionales para la prevención, detección temprana, tratamiento oportuno y remisión segura de las complicaciones obstétricas que ponen en riesgo la vida materna.
El instrumento aborda de manera integral los ítems críticos en la secuencia lógica del proceso asistencial, desde el ingreso por Urgencias, admisiones, sala de partos, cirugía y servicios complementarios, incorporando los componentes estructurales de los paquetes de intervención (bundles) recomendados por OMS, FIGO y la Alianza por la Innovación en Salud Materna. Su evaluación se orienta a cuatro líneas estratégicas:

1. Preparación institucional.
2. Prevención y reconocimiento de complicaciones. Respuesta a la emergencia obstétrica.
3. Remisión en condiciones que salvan vidas.
4. Reporte, aprendizaje institucional, respeto y humanización.

Durante la revisión conjunta de cada ítem se evidencian avances relevantes en la operativización de los componentes críticos.

- El Triage Obstétrico se encuentra Se esta implementado, el triage lo aplica enfermera profesional, cuando es triage 1 se activa el ERR. Los tiempos de atención son mínimos gracias a

la valoración directa en el consultorio de Ginecología y la existencia de un proceso de clasificación de riesgos en Urgencias.

- En cuanto a la Escala de Alerta Temprana en Emergencia Obstétrica, se presentan avances con mayor adherencia y reconocimiento de todo el talento humano, se realizó capacitación a todo el personal el 11 de noviembre de 2025. De esta manera similar, en relación con la estrategia de comunicación SBAR y asa cerrada, se evidencia apropiación y operatividad de la historia clínica.
- Tienen un mecanismo estandarizado de comunicación en casos de SBAR, Todo el personal está capacitado en ERR y mecanismo estandarizado de comunicación - el ERR se activa por medio de WhatsApp, timbre y llamada.
- Cuentan con capacitación del personal, realizado por la Universidad nacional /hospital universitario nacional, en salud digital y telesalud. Cuentan con los equipos.
- Cuentan con protocolo socializado con Código GA-C-PD-001PROCEDIMIENTO DE ATENCION POR TELEMEDICINA.
- Cuentan con número telefónico para teleapoyo 3102090313 el cual es el mismo de referencia y contrarreferencia las 24 horas. Código GA-C-PD-001PROCEDIMIENTO DE ATENCION POR TELEMEDICINA
- La institución cuenta con un equipo de respuesta rápida claramente definido, con documentación estandarizada y mecanismos de activación por radio y teléfono. En la verificación del caso clínico HC 1101177747 reconocimiento de signos de alarma MEOWS 6 y triage obstétrico de 2 por sepsis obstétrica, recibió valoración inmediata por ginecólogo de turno, activación de respuesta rápida y emergencia obstétrica, manejo inicial con inicio de antibioticoterapia en la 1er hora. También se verifica caso clínico HC 63559681 se activa emergencia obstétrica y equipo de respuesta rápida para preeclampsia severa-eclampsia, manejo inmediato con sulfato de magnesio, monitorización continua, traslado a UCI. Se confirma la disponibilidad de kits completos de emergencia obstétrica y la evaluación adecuada de factores de riesgo y escalas de alerta.
- Extracción manual de placenta se realiza siempre bajo anestesia-Oferta de Analgesia peridural: Cuentan con anestesiólogo sin embargo sin disponibilidad exclusiva para ginecobstetricia, tienen proyectado inicio de exclusividad para diciembre de este año. Se puntualiza en iniciar pasos encaminados a garantizar que toda mujer pueda acceder al derecho de recibir métodos eficaces y seguros para el alivio del dolor durante el trabajo de parto (ello incluye la analgesia neuro axial). Se recuerda que las contraindicaciones de la analgesia neuro axial durante el trabajo de parto son: rechazo de la madre, coagulopatía, infección local o sistémica o hipovolemia no corregida y para extracción manual de placenta.
- Cuenta con sistema para la medición de adherencia para la adherencia de guías de prácticas clínicas que salvan vidas.

- Se entrega ENLACE CAJA DE HERRAMIENTAS SSR:

https://boyacagob-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fsalud%5Fsexualyreproductiva%5Fboyaca%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEQUIPO%20SSR%202025%2FCAJA%20DE%20HERRAMIENTAS%20DSDSR%202025%2FSALUD%20MATERNA&ga=1

- con información específica de la línea de maternidad segura (PARE MM, Emergencias obstétricas, circulares y memorandos del departamento, redes sociales y comunitarias, capacitaciones realizadas en el marco del PARE MM)

- Se recuerda la asistencia a las unidades de seguimiento territoriales todos los miércoles a las 2:00 p.m. en el siguiente enlace de conexión

- https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YWM3NjBlNWUtOTM1Ni00NmZiLWFhOTktYzgzNTI3OTkzNTMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22620104e2-1390-43c5-ba45-85d1883cc488%22%2c%22Oid%22%3a%22acb15f65-18fc-4adc-991f-ac3ff748607b%22%7d

La IPS	ESE HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA	En la aplicación del instrumento ISABEL; Evaluación de la Respuesta Institucional frente a la Emergencia Obstétrica obtuvo un puntaje de **100%**

COMPROMISOS

No.	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	META	PLAZO	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
1	**Avanzar en el plan institucional para garantizar la oferta de analgesia obstétrica segura y oportuna**, incluyendo ajuste de procesos, dotación y organización del recurso humano en anestesiología.	Lograr en las gestantes en trabajo de parto que analgesia obstétrica segura y oportuna según lo establecido por el protocolo institucional.	2 meses	Coordinación médica, Coordinación de Enfermería, Auditores, Ginecólogos, Profesionales que atienden gestantes, profesionales de apoyo.	2 meses	DPS – Dirección de prestación de servicios IVC

OBSERVACIONES

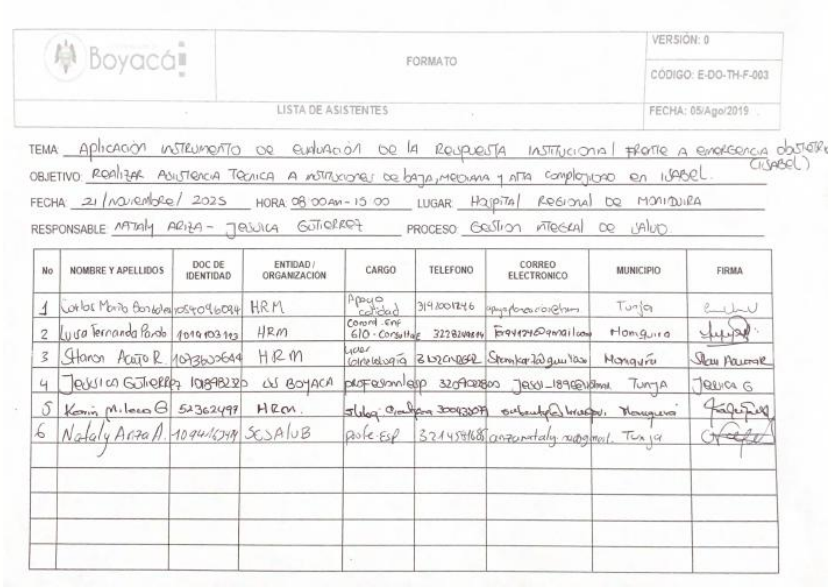
- Continuar garantía de condiciones de alta segura en Paciente Obstétrica:
  1. Garantía de asesoría y provisión de anticoncepción post evento obstétrico de larga duración o definitivo, de acuerdo con los criterios de elegibilidad OMS y elección de la usuaria. Retroalimentar a IPS que se identifiquen con baja adherencia a la provisión de asesoría anticoncepción post evento obstétrico y remitir informe al programa de Salud Sexual y Reproductiva de SESALU, para realizar el respectivo seguimiento, correo salud.sexualyreproductiva@boyaca.gov.co
  2. Garantía de los medicamentos necesarios para el tratamiento ambulatorio completo en caso de MME (Ninguna IPS puede dar de alta a la mujer sin que se le haya hecho entrega efectiva de los antibióticos, antihipertensivos, trombo profilaxis, analgésicos, etc. necesarios para el manejo). En caso de que no se tenga en proceso contra actual establecer mecanismo de comunicación con la aseguradora para que garanticen entrega oportuna antes del egreso.
  3. Cita agendada de control postparto entre los 3 y 5 días posteriores al alta, para la usuaria y el recién nacido: cita agendada en los primeros 7 días con Ginecología, medicina materno fetal o especialidades de acuerdo con lo requerido: en caso de que la usuaria con evento de MME en gestación.
  4. Garantía de educación y comprensión de los signos de alarma para reconsultar, por parte de la usuaria y su familia.
  5. En caso de que la usuaria requiera albergue u HOGAR DE PASO por residencia en municipio rural disperso la EAPB/EPS debe garantizarlo en el territorio de la IPS de seguimiento de mayor complejidad.

- Informar inconsistencias al correo salud.sexualyreproductiva@boyaca.gov.co
- Próxima Visita en 2 meses; por indicación del Ministerio de Salud, a las Instituciones del PARETO (que atienden el mayor número de partos en el departamento) se les realizará mínimo 4 visitas en el año, para seguimiento de la aplicación de la estrategia del Plan de aceleración para la Reducción de la Mortalidad Materna.

Anexo 1. Evidencia fotográfica



Anexo 2. Lista de Asistencia



Boyacá | FORMATO | VERSIÓN: 0 | CÓDIGO: E-DO-TH-F-003 | LISTA DE ASISTENTES | FECHA: 05/Ago/2019

TEMA: Aplicación instrumento de evaluación de la respuesta institucional frente a emergencia obstétrica (SIVIGE)

OBJETIVO: Realizar asistencia técnica a instituciones de baja, mediana y alta complejidad en SIVIGE

FECHA: 21/noviembre/2025 HORA: 08:00am - 15:00 LUGAR: Hospital Regional de Moniquirá

RESPONSABLE: Nataly Ariza - Jessica Gutierrez PROCESO: Gestión integral de salud

No	NOMBRE Y APELLIDOS	DOC DE IDENTIDAD	ENTIDAD / ORGANIZACION	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	MUNICIPIO	FIRMA
1	Carlos Mario Bonilla	1054096094	HRM	Apoyo calidad	3142001246	apoyocalidad@hrm.com	Tunja	
2	Luisa Fernanda Pardo	1019103393	HRM	Coord. Enf. 610 - Consulta	3228214444	Enf4174@gmail.com	Moniquira	
3	Sharon Acuña R.	1073630649	HRM	Líder calidad y SIVIGE	3132168892	Sharonacuna20@gmail.com	Moniquira	
4	Jessica Gutierrez	1098982220	SS BOYACA	profesional esp	3209428800	Jessi-1898@hotmail.com	Tunja	
5	Kevin M. Lozano G.	52362497	HRM.	Líder calidad	3006138078	subcalidad@hrm.gov.co	Moniquira	
6	Nataly Ariza M.	1074151749	SSSA/LAB	profesional	3214594687	arizamontaly@gmail.com	Tunja	

Anexo 3. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN ISABEL en el cual se contemplan los hallazgos encontrados,

se recomienda usar el instrumento para autoevaluación continúa.

El instrumento debe incorporarse de manera sistemática en uno de los procesos de mejoramiento de la calidad de la entidad que lo opera. En la Entidad territorial como acción de IVC, o como parte del proceso de auditoria en una EPS o en el PAMEC en la IPS.

Elaboró: Nataly del Pilar Ariza Acevedo -Jessica Paola Gutiérrez Castellanos
Profesionales Especializados del programa salud sexual y reproductiva. Línea maternidad segura
Dirección de Promoción y Prevención en Salud
Secretaría de Salud de Boyacá